EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 84045
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-07 12:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE ISIDRO VALDEBENITO OSSES			RUN	: 5.888.046-9
F.Nac	: 15-10-1948	Edad	: 75 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-05	Fecha Egreso	: 2024-05-07 12:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1- Epoc GOLD E Exacerbado (MmRC: 4 CAT: 32 Pts)
a.NAC Crub 65: 1pto / PSI: 95pts
b. Usuario de O2 Domiciliario
2. TVP recurrente en TACO
3. ERC IIIb
3. HTA
4. DM IR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15-NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I82-OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N18-ENFERMEDAD RENAL CRONICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 71 años con antecedentes de EPOC GOLD E, en tratamiento, usuario de O2 domiciliario 1Lt, ingresa por cuadro de 2 dias de evolucion caracterizado por fiebre cuantificada, tos con expectoración y compromiso del estado general, al ingreso destaca leucocitosis 18.000 y PCR 36, se solicita Rx de torax de ingreso que destaca infiltrado en base izquierdo, paciente durante su hospitalizacion se ha mantenido hemodinamicamente estable, normotenso, eucardico, eupneico, afebril, actualmente vuelve a requerimientos basales de 1L de O2 por NRC para lograr sat 94%, actualmente refiere leve dificultad respiratoria, con menos compromiso que dias anteriores, actualmente sin tos, sin expectoracion, con buena tolerancia al decubito, alimentacion via oral y diuresis presente, dada evolucion favorable clinica y paraclinica, se decide alta medica para continuar con tratamiento en HODOM.

PLAN DE MANEJO:

- Continuar tratamiento antibiotico con ceftriaxona EV en Hospitalizacion domiciliaria hasta completar 7 dias
- Continuar tratamiento cronico y oxigenoterapia en domicilio

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo Relativo, semisentado
2. 2. Regimen hiposodico diabetico
3. 3. Continuar O2 en domicilio

4. 4. Ceftriaxona 2gr EV /dia hasta completar 7 dias
5. 5. Hidrocortisona 100mg c/12 horas EV
6. 6. Spriva 1 puff c/dia
7. 7. Bromuro de ipatropio 4 puff cada 6 horas
8. 8. Salmeterol 2 puff c/12 horas
9. 9. Salbutamol 2 puff c/6 horas
10. 10. Dabigatran 150mg c/12 hrs vo
11. 11. Hidralazina 50mg c/12 hrs vo
12. 12. Atorvastatina 20mg c/noche
13. 13. Amlodipino 5mg c/dia vo
14. 14. Azitromicina 500mg 1 c/dia vo
15. 15. Cuidados de enfermeria/PUPP
16. 16. Avisar eventualidad a residente

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO